

PITCH DE 3 MINUTOS | CENTELHA 3 RONDÔNIA

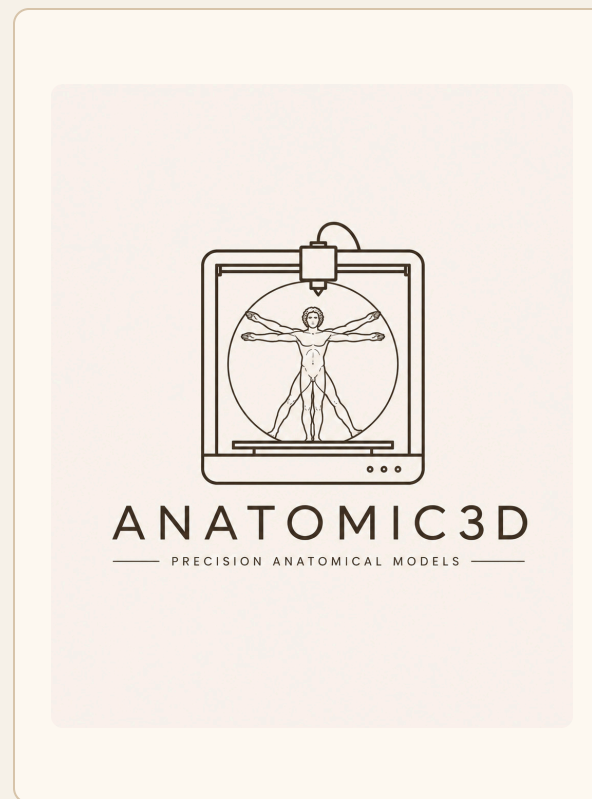
Modelos anatômicos personalizados para cirurgias mais previsíveis

Transformamos CT e MRI em modelos físicos ou digitais para planejamento pré-operatório, com IA, revisão técnica e impressão 3D.

Vilhena, RO

Validação técnica inicial

Foco em segurança cirúrgica



PROBLEMA

O exame é tridimensional. O planejamento ainda é, muitas vezes, bidimensional.

Em cirurgias complexas, a incerteza espacial pode aumentar tempo de sala, risco hemorrágico e custo assistencial.

O cirurgião precisa antecipar relações entre vasos, ossos, lesões e trajetórias antes do procedimento.



Incerteza anatômica

Relações espaciais críticas ficam difíceis de visualizar em cortes 2D.



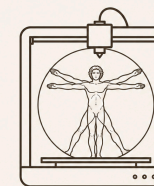
Risco hemorrágico

Menor previsibilidade sobre vasos e estruturas sensíveis.



Impacto operacional

Decisões que poderiam ser planejadas antes migram para dentro da sala cirúrgica.



ANATOMIC3D
— PRECISION ANATOMICAL MODELS —

Da imagem médica ao modelo personalizado

1

DICOM

CT ou MRI do paciente.

2

IA + revisão

Segmentação anatômica com controle técnico.

3

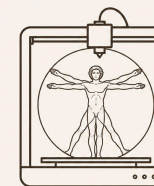
Malha 3D

Conversão para STL ou OBJ.

4

Entrega clínica

Modelo físico, digital ou aplicação especializada.



ANATOMIC3D

PRECISION ANATOMICAL MODELS

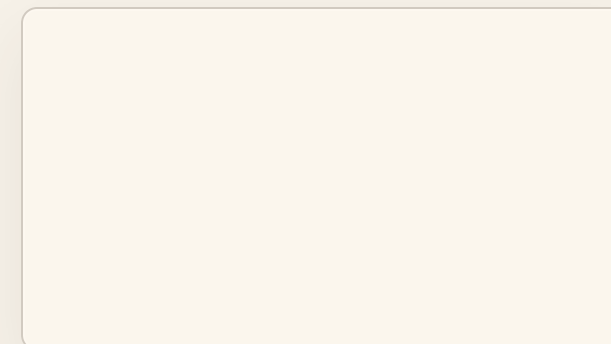


A proposta não substitui a decisão clínica. Ela entrega uma representação individual para reduzir incerteza antes da cirurgia.

Planejamento

Treinamento

Comunicação da equipe



A tecnologia já foi testada ponta a ponta. O fomento acelera a operação.

Estágio atual

- Fluxo DICOM, segmentação, Marching Cubes, STL, fatiamento e impressão física executado em casos de teste.
- Modelos físicos de estruturas ósseas avaliados quanto à fidelidade geométrica.
- Stack com 3D Slicer, MONAI, TotalSegmentator, MeshLab e Blender.

Por que agora

- IA reduziu o esforço manual de segmentação.
- Ferramentas open source diminuem custo de licenciamento.
- Impressão 3D viabiliza operação regional com escala digital futura.

15% a 35%

potencial de redução de tempo de sala citado na literatura do projeto

5+

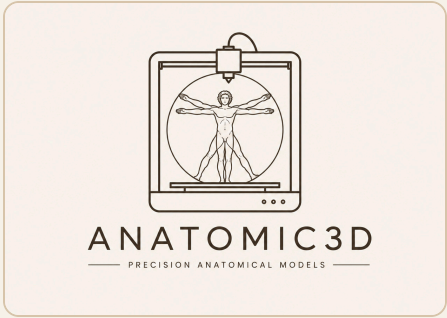
casos piloto como meta nos primeiros 6 meses

12 meses

para serviço assistido, operação comercial inicial e MVP SaaS



Começar como serviço especializado. Escalar como plataforma.



Por caso

Modelo personalizado para demanda clínica específica.

R\$ 1.500 ticket projetado



Institucional

Pacotes mensais com hospitais, clínicas e ensino.

R\$ 6 mil a R\$ 15 mil/mês projetados



SaaS pós-projeto

Upload DICOM, modelagem automatizada e entrega digital.

R\$ 30 mil+/mês projetados

MESES 1-6

Serviço assistido e casos piloto regionais.

MESES 7-12

Primeiros pedidos pagos e MVP do pipeline SaaS.

PÓS-PROJETO

Entrega digital e expansão nacional.

IA, engenharia de software e computação científica aplicadas à saúde



Juliano

Doutor em Ciência da Computação

Responsável técnico, estratégico, comercial e administrativo; liderança em IA, software, segmentação médica, malhas 3D e arquitetura SaaS.



Roberto Simplicio Guimarães

Analista de Sistemas e Mestre em Engenharia Nuclear pelo IPEN/USP

Apoio técnico-operacional em imagem médica, computação científica, segmentação anatômica, modelagem 3D e controle de qualidade.

Complementaridade: IA + engenharia de software + imagem médica + controle técnico para transformar exames em modelos anatômicos personalizados.

